

**Série De Préparation A L'examen D'accès Au Troisième Cycle
Des Etudes Médicales**

Thème 22 : Douleurs thoraciques aiguës

Pr Mehdi SLIM

Dr Houda GHARDALLOU

QCM

- 1) Concernant la prise en charge initiale d'une douleur thoracique aiguë aux urgences :**
- A. L'interrogatoire du patient et de l'entourage peut être différé en cas de douleur évocatrice d'une urgence vitale.
 - B. L'électrocardiogramme doit être réalisé dans les 10 minutes suivant l'arrivée du patient.
 - C. Les causes cardiovasculaires doivent être recherchées en priorité, compte tenu de leur gravité potentielle.
 - D. L'intensité de la douleur oriente de façon fiable vers la gravité de l'étiologie.
 - E. La présence de signes cliniques de gravité justifie une prise en charge en unité de soins intensifs ou en unité de surveillance continue.
- 2) Parmi les signes cliniques suivants, lesquels doivent être considérés comme des éléments de gravité devant une douleur thoracique aiguë ?**
- A. Diminution inspiratoire du pouls radial
 - B. Douleur thoracique reproduite à la palpation et à l'inspiration profonde
 - C. Présence d'une respiration abdominale
 - D. Fièvre à 39°C isolée
 - E. Syncope
- 3) Un homme de 60 ans consulte pour une douleur thoracique aiguë brutale, transfixiante, irradiant vers le dos. Il est polypnéique à 34/min, SaO₂ à 89 % à l'air ambiant, TA à 85/60 mm Hg. L'auscultation cardiaque est difficile, les BDC sont assourdis. Vous êtes aux urgences. Quelle(s) est (sont) la(les) conduite(s) à tenir immédiatement justifiée(s) dans ce contexte ?**
- A. Mise sous monitoring cardiaque et scope dès l'arrivée aux urgences
 - B. Réalisation immédiate d'un ECG 12 dérivations
 - C. Injection de morphine en sous cutané et de trinitrine en sublingual
 - D. Appel du réanimateur et préparation à une éventuelle intubation
 - E. Angioscanner thoracique sans délais

- 4) Une douleur thoracique aiguë associée à un état de choc, des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë et une auscultation pulmonaire normale vous fait évoquer :**
- A. Une embolie pulmonaire grave
 - B. Un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST inférieur compliqué d'une rupture du pilier de la valve mitrale
 - C. Un pneumothorax compressif bilatéral
 - D. Une dissection aortique de type B compliquée
 - E. Une tamponnade cardiaque
- 5) Monsieur M, âgé de 75 ans consulte aux urgences pour une douleur thoracique aiguë associée à une syncope. Son examen clinique révèle une TA systolique à 90 mm Hg qui chute à 70 mm Hg en inspiration, des extrémités froides, une turgescence spontanée des veines jugulaires. Vous suspectez en premier (indiquer la réponse exacte) :**
- A. Un syndrome coronarien avec sus-décalage de ST et extension au ventricule droit
 - B. Une crise d'asthme aigu grave
 - C. Une embolie pulmonaire grave
 - D. Une dissection aiguë compliquée d'une rupture dans le péricarde
 - E. Une compression médiastinale d'origine tumorale
- 6) Une douleur thoracique est dite typique d'angine de poitrine si elle associe les caractéristiques suivantes :**
- A. Siège thoracique antérieur
 - B. Durée brève de quelques secondes
 - C. Type constriction
 - D. Précipitée par l'effort physique
 - E. Soulagement rapide par la trinitrine en sublingual
- 7) Une douleur thoracique est suggestive d'une ischémie myocardique si :**
- A. Elle s'aggrave à l'effort et le stress émotionnel
 - B. Elle cède progressivement en quelques minutes après l'arrêt de l'effort
 - C. Il existe un souffle mitral systolique à l'examen physique
 - D. Elle s'associe à des signes neurovégétatifs (nausées, vomissements, sudation profuse)
 - E. Il existe une anisotension > 20 mm hg
- 8) L'origine pleurale d'une douleur thoracique aiguë peut être suspectée devant :**
- A. Le caractère unilatéral de la douleur
 - B. Le caractère constrictif de la douleur
 - C. L'amélioration en position couchée
 - D. L'augmentation des douleurs par la toux
 - E. La variation de son intensité avec les mouvements respiratoires

9) La (les) caractéristique (s) sémiologique (s) suivante (s) vous fait (font) évoquer une origine péricarditique d'une douleur thoracique aiguë :

- A. Irradiation vers le cou et les muscles trapèzes
- B. Installation brutale
- C. Evolution par paroxysmes
- D. Amélioration par la position assise penchée en avant
- E. Soulagement par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

10) Le frottement péricardique :

- A. Est un bruit systolique pathognomonique de la péricardite aiguë
- B. Mieux entendu au niveau du foyer mitral, en bord gauche du sternum
- C. Varie avec la respiration et la position du patient
- D. Disparaît en apnée
- E. Son intensité augmente avec l'abondance de l'épanchement péricardique

11) Une douleur thoracique exacerbée par la toux peut se voir dans :

- A. La névralgie intercostale
- B. La péricardite aiguë
- C. Le reflux gastro-œsophagien
- D. La pneumonie franche lobaire aiguë
- E. L'embolie pulmonaire

12) La douleur thoracique dans la dissection aortique est typiquement :

- A. Brutale, d'intensité d'emblée maximale
- B. Continue et à exacerbation nocturne
- C. A type de constriction ou de brûlure
- D. Migratrice
- E. Calmée par le repos et l'antéflexion

13) Indiquer la ou les proposition (s) exactes : la douleur thoracique dans la dissection aortique :

- A. Constitue le signe fonctionnel le plus fréquent
- B. Est d'installation brutale
- C. Est typiquement à type de constriction ou de brûlure
- D. Le caractère migrateur est constant
- E. Est d'aggravation progressive

14) Les caractéristiques de la douleur thoracique prises en compte dans l'évaluation de la probabilité clinique d'une dissection aiguë de l'aorte sont :

- A. Son type, déchirure
- B. Son installation brutale
- C. Son caractère migrateur
- D. Sa durée d'évolution prolongée
- E. Son irradiation dorsale

15) Une dissection aigue de l'aorte est suspectée par l'examen clinique d'un patient admis pour une douleur thoracique aigue en cas de la présence ?

- A. Une asymétrie tensionnelle entre les deux bras > 20 mm Hg
- B. Un souffle d'insuffisance aortique
- C. Un élargissement de la pression artérielle différentielle
- D. Un pic hypertensif concomitant
- E. Une hyperpulsatilité artérielle

16) En cas de douleur thoracique aigue, une dissection aigue de l'aorte de type B est évoquée devant :

- A. L'installation concomitante d'un déficit neurologique focal
- B. Une douleur dorsale en coup de poignard irradiant vers l'abdomen
- C. Une asymétrie de pouls entre les membres supérieurs
- D. L'apparition récente d'un souffle diastolique aortique
- E. Une diminution du murmure vésiculaire avec un tympanisme à la base pulmonaire droite

17) Les complications possibles d'une dissection aortique de type B :

- A. Une ischémie mésentérique
- B. Un syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST
- C. Un hemothorax droit
- D. Une tamponnade par hémopéricarde
- E. Une paraplégie

18) Une patiente âgée de 35 ans et suivie pour un lupus érythémateux disséminé, consulte pour des précordialgies aggravées par l'inspiration profonde et évoluant depuis 06 heures. Vous évoquez le diagnostic de péricardite aigue devant :

- A. L'antécédent de lupus érythémateux disséminé
- B. Les caractéristiques sémiologiques de sa douleur thoracique
- C. La présence d'un frottement péricardique
- D. La présence d'un sus-décalage de l'intervalle PQ à l'électrocardiogramme
- E. La présence d'un sus-décalage concave en antérieur du ST à l'électrocardiogramme

19) Le ou les signe (s) électrocardiographiques (s) compatible (s) avec le diagnostic d'une embolie pulmonaire est/sont:

- A. Un allongement de QT
- B. Un sous décalage du PQ
- C. Un bloc de la branche droite complet ou incomplet
- D. Une rotation axiale droite avec aspect S1Q3
- E. Une inversion de l'onde T de V1 à V3

20)Devant un tableau clinique évocateur, le diagnostic d'une tamponnade cardiaque est suspecté sur l'électrocardiogramme par la présence de :

- A. Une alternance électrique
- B. Un sous décalage du segment PQ
- C. Un micro voltage diffus
- D. Un sus-décalage de ST diffus avec miroir
- E. Une rotation axiale droite

21)Concernant l'ECG dans la tamponnade cardiaque, indiquer la ou les proposition(s) exacte(s) ?

- A. Le microvoltage est un signe sensible mais non spécifique
- B. L'alternance électrique est pathognomonique mais rare
- C. La tachycardie sinusale peut être absente chez les patients sous bêtabloquants
- D. Un bloc auriculoventriculaire complet est fréquent
- E. Les troubles de la conduction intraventriculaires orientent vers la sévérité de la tamponnade

22)Concernant le dosage des D-Dimères dans l'embolie pulmonaire :

- A. A une forte valeur prédictive négative.
- B. Un premier dosage négatif doit être refait 6 heures après.
- C. Sa spécificité diminue avec l'âge du patient.
- D. Sa négativité chez les patients à probabilité élevée permet d'écarter le diagnostic.
- E. Son taux diminue de façon progressive au cours de la grossesse.

23)Un patient âgé de 60 ans sans antécédents pathologiques se présente aux urgences pour une douleur thoracique récidivante. Le dernier épisode a débuté 7 heures avant l'admission à l'hôpital. L'examen physique et L'ECG sont normaux. Le taux initial de troponines US est normal à 4 ng/L (ULN < 14 ng/L). Indiquer la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le diagnostic d'infarctus du myocarde peut être éliminé
- B. Une origine coronaire à cette douleur thoracique peut être écartée
- C. Un dosage des troponines US après 3 heures est nécessaire
- D. Les étiologies non coronaires des douleurs thoraciques doivent être envisagées
- E. Un retour à domicile avec un Coro scanner à distance peut être indiqué

24)Une embolie pulmonaire est considérée à haut risque devant :

- A. Troponine-T positive, au moins 3 fois la limite supérieure de référence.
- B. Un score PESI simplifié ≥ 3 .
- C. Hypotension artérielle > 15 minutes avec oligurie.
- D. Taux de NT-pro BNP > 600 pg/mL.
- E. Syncope

25)Concernant la stratification du risque dans l'EP, quelles propositions sont correctes ?

- A. Les patients à haut risque doivent recevoir une thrombolyse ou une embolectomie si contre-indication
- B. Les patients à faible risque peuvent être pris en charge en ambulatoire sous surveillance adaptée
- C. Les patients à risque intermédiaire haut doivent être surveillés étroitement en milieu monitoré
- D. Les patients à faible risque ne nécessitent pas d'anticoagulation
- E. Les patients à haut risque ont une mortalité hospitalière > 15 %

26)Un homme de 32 ans, opéré pour une coarctation de l'aorte au jeune âge et suivi pour une HTA résiduelle sous inhibiteurs calciques, consulte les urgences pour l'installation brutale de douleurs thoraciques intenses. A l'examen : TA = 100/50 mm Hg au membre supérieur droit ; 70/50 mm Hg au membre supérieur gauche ; FC= 130 BPM. Vous suspectez le diagnostic d'une dissection aigue de l'aorte.

- A. La prise en charge diagnostique chez ce patient est basée sur le calcul de la probabilité pré-test de dissection aortique
- B. Un dosage des D-dimères négatif permet d'éliminer le diagnostic de dissection aortique
- C. Une échographie cardiaque transthoracique doit être réalisée en première intention
- D. Une échocardiographie transthoracique normale permet d'exclure une dissection de type A
- E. Une échocardiographie transoesophagienne est indiquée au bloc opératoire si l'angioscanner est non faisable

27)Un homme de 45 ans est hospitalisé pour douleur basithoracique droite et dyspnée d'effort. L'examen clinique est normal en dehors d'une tachycardie régulière à 100 BPM. Les D-dimères sont à 2000 mg/ml. L'angioscanner thoracique confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire lobaire droite. Afin de stratifier le risque de son embolie pulmonaire vous demandez :

- A. Un dosage des troponines ultrasensibles
- B. Un dosage de la CRP
- C. Une gazométrie sanguine
- D. Un électrocardiogramme 12 dérivations
- E. Une échocardiographie transthoracique

28)Concernant la probabilité pré-test orientant les examens complémentaires pour le diagnostic d'embolie pulmonaire sans instabilité hémodynamique en urgence :

- A. Elle intègre l'évaluation des facteurs cliniques, biologiques et radiologiques à l'admission.
- B. Son estimation s'appuie principalement sur des scores cliniques validés tels que Wells ou Genève.
- C. La stratification de la probabilité clinique distingue classiquement quatre niveaux pour orienter la prise en charge.
- D. En situation de probabilité faible ou intermédiaire, un D-dimère négatif permet d'exclure l'embolie pulmonaire sans recours à l'imagerie.
- E. En présence d'une forte probabilité clinique, un angioscanner thoracique normal élimine avec certitude le diagnostic.

29)Concernant le score PESI dans l'embolie pulmonaire, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

- A. Evalue le risque de récurrence de l'embolie pulmonaire à 6 mois
- B. N'est pas recommandé chez les patients d'âge > 80 ans
- C. La version simplifiée sPESI attribue 1 point par facteur de risque présent
- D. Permet d'identifier les patients à faible risque
- E. Nécessite une échocardiographie pour être calculé

30)Un homme de 72 ans est hospitalisé pour une embolie pulmonaire confirmée par angio-TDM. Sa TA est de 140/90 mm Hg, FC 100/min, sans signes de défaillance d'organe. Le score PESI simplifié est de 3. À propos de la stratification du risque et de la prise en charge initiale de cette embolie pulmonaire, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'embolie pulmonaire est classée à haut risque car le score de sPESI est ≥ 3
- B. L'association d'une dysfonction VD à l'imagerie ou d'une élévation des troponines permet de classer ce patient en risque intermédiaire haut.
- C. La négativité des troponines cardiaque permet de classer ce patient en risque intermédiaire bas
- D. La stabilité hémodynamique permet d'envisager une sortie précoce du patient.
- E. Une surveillance en unité de soins intensifs peut être justifiée en cas de risque intermédiaire haut

31) Une femme de 80 ans est admise aux urgences pour une douleur basithoracique aiguë associée à une dyspnée sévère. À son arrivée, sa pression artérielle est à 80/50 mm Hg, sa fréquence cardiaque à 130 BPM, sa fréquence respiratoire à 32/min, et sa saturation en oxygène est de 87 % sous oxygène à 6 L/min. L'électrocardiogramme montre une tachycardie sinusale avec des ondes T négatives en V1-V3. Quelle(s) démarche(s) diagnostique(s) initiale(s) privilégieriez-vous ?

- A. Estimer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire à l'aide des scores de Genève ou de Wells
- B. Réaliser une échocardiographie transthoracique au lit
- C. Effectuer un dosage des D-dimères avec un seuil ajusté selon l'âge ou la probabilité clinique pour exclure l'embolie pulmonaire
- D. Transférer immédiatement en salle de cathétérisme cardiaque pour confirmer ou exclure embolie pulmonaire, infarctus du myocarde et dissection aortique lors d'un même examen
- E. Réaliser une échocardiographie transœsophagienne si l'examen transthoracique est non concluant

32) Une femme de 81 ans présente une embolie pulmonaire avec une pression artérielle à 110/60 mm Hg, une fréquence cardiaque de 120 BPM et une saturation en oxygène à 94 % en air ambiant. Dans quelle (s) condition (s) cette embolie peut-elle être classée à risque intermédiaire bas ?

- A. Échocardiographie transthoracique normale et troponines dans les normes
- B. Dilatation isolée du ventricule droit observée à l'angioscanner thoracique
- C. Élévation des troponines sans anomalie ventriculaire droite
- D. Présence d'un thrombus mobile dans le ventricule droit en échocardiographie transthoracique
- E. Présence isolée d'une tachycardie sinusale persistante > 110 BPM

33) Un homme de 45 ans, sans antécédent cardiovasculaire documenté, consulte pour une douleur thoracique très intense survenue brutalement, transfixiante, à type de déchirure et irradiant vers le dos. Sa TA est de 145/70 mm Hg symétrique. Le reste de l'examen est normal. L'ECG est normal. Le premier examen que vous réalisez est :

- A. Dosage des D-Dimères
- B. Angioscanner thoracique
- C. Echocardiographie transthoracique au lit
- D. Dosage des troponines
- E. Radiographie du thorax

34) Concernant le dosage des D-dimères dans la dissection aiguë de l'aorte, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A. Une valeur > 500 µg/L permet de poser le diagnostic
- B. Une valeur normale (< 500 µg/L) exclut le diagnostic
- C. Ils sont inutiles dans un contexte de faible suspicion clinique
- D. Leur dosage est recommandé chez des patients stables
- E. Ils permettent de différencier une dissection de type A d'une dissection de type B

35)Devant une forte suspicion clinique d'une dissection aortique avec instabilité hémodynamique :

- A. L'IRM cardiaque est l'examen de première intention.
- B. L'échocardiographie transthoracique peut être réalisée en première intention au lit du patient.
- C. En cas de suspicion de dissection de type A, un avis chirurgical urgent est requis avant toute imagerie.
- D. L'échographie transœsophagienne est l'examen de choix en cas de suspicion de dissection de type A.
- E. Un traitement antihypertenseur doit être initié rapidement, même avant la confirmation par l'imagerie.

Cas clinique 1

Un homme de 62 ans, hypertendu, fumeur chronique, est admis aux urgences pour une dyspnée aiguë associée à une douleur thoracique latéralisée droite, syncope. Il rapporte une chirurgie orthopédique récente (pose de prothèse de genou il y a 10 jours). À l'examen, sa TA est à 130/70 mm Hg, FC à 110/min, FR à 28/min, saturation en O₂ à 89 % en air ambiant. Il est apyrétique. L'ECG montre une tachycardie sinusale sans signe d'ischémie. L'échocardiographie réalisée au lit du patient met en évidence une dilatation du VD avec hypokinésie septale.

1) Quel score clinique est le plus adapté pour estimer la probabilité pré-test d'embolie pulmonaire chez ce patient ?

- A. Score Wells
- B. Score CHA₂DS₂-VASc
- C. Score HAS-BLED
- D. Score PESI simplifié
- E. Score TIMI

2) Quel élément du tableau clinique augmente le risque de mortalité à court terme chez ce patient ?

- A. Antécédent de chirurgie récente
- B. Tachycardie à 110/min
- C. Dilatation du ventricule droit à l'échocardiographie
- D. Saturation en O₂ à 89 %
- E. Douleur thoracique latéralisée

3) Quelle est la démarche diagnostique la plus appropriée pour ce patient ?

- A. Dosage des D-dimères
- B. Angioscanner thoracique
- C. Angiographie pulmonaire invasive
- D. Echo-Doppler des membres inférieurs
- E. IRM thoracique

4) L'embolie pulmonaire est confirmée. Quelle prise en charge initiale est la plus appropriée ?

- A. Anticoagulation en ambulatoire
- B. Hospitalisation et anticoagulation immédiate
- C. Thrombolyse intraveineuse
- D. Embolectomie chirurgicale
- E. Embolectomie percutanée

Cas clinique 2

Monsieur C.T, 34 ans, est transporté aux urgences de votre hôpital pour une douleur thoracique. Cette douleur est survenue une heure auparavant, de manière brutale, alors qu'il faisait un footing. Le patient vous décrit cette précordialgie comme un « coup de poignard » partant dans la poitrine et irradiant dans le dos. Il n'existe aucun antécédent connu hormis une forte myopie. L'examen clinique retrouve une tension artérielle à 170/90 mm Hg, un pouls à 100 BPM et une apyrexie. La taille est de 1.95 m pour 71 kg. L'ECG est normal, hormis une tachycardie sinusale. Une dissection aortique est suspectée.

1) En faveur de ce diagnostic vous retenir :

- A. Le terrain
- B. Les caractéristiques de la douleur
- C. La normalité de l'électrocardiogramme
- D. La poussée hypertensive
- E. La tachycardie

2) Les éléments suivants de l'examen physique permettent de conforter ce diagnostic :

- A. Anisotension > 20 mm Hg
- B. Abolition d'un pouls fémoral
- C. Souffle diastolique au bord gauche du sternum
- D. Hyperpulsatilité artérielle
- E. Souffle systolique sur le trajet de la carotide interne gauche

3) La pathologie sous-jacente la plus probable serait :

- A. Une coarctation de l'aorte
- B. Une bicuspidie aortique
- C. Une maladie de Marfan
- D. Un syndrome de Turner
- E. Une toxicomanie

4) L'examen complémentaire à demander ici en première intention pour confirmer le diagnostic est :

- A. Un angioscanner thoracique
- B. Un dosage de D-Dimères
- C. Une échographie cardiaque transthoracique
- D. Une échographie cardiaque transoesophagienne sous sédation
- E. Une angio-IRM thoracique

Cas clinique 3

Un homme de 58 ans, hypertendu mal contrôlé, tabagique, sans antécédent coronarien connu, consulte aux urgences pour une douleur thoracique brutale, transfixiante, irradiant dans le dos et les lombes, survenue au repos, accompagnée de sueurs froides et d'une sensation d'angoisse. À son arrivée, il est pâle, agité, avec une TA droite à 70/60 mmHg, TA gauche à 100/ mmHg, pouls à 110 bpm, polypnéique à 26/min, SaO₂ à 94% sous air ambiant. Les pouls fémoraux sont faibles et asymétriques. À l'auscultation : souffle diastolique au foyer aortique, crépitants bilatéraux aux bases pulmonaires. ECG : tachycardie sinusale, sous décalage diffus du segment ST. La troponine est légèrement élevée.

1) Quels diagnostics doivent être envisagés en priorité dans ce contexte de douleur thoracique aiguë ?

- A. Syndrome coronarien aigu compliqué
- B. Embolie pulmonaire massive
- C. Dissection aortique
- D. Péricardite aiguë
- E. Pneumothorax spontané

2) Parmi les éléments suivants, lesquels sont les plus spécifiques d'une dissection aortique type A par rapport à d'autres étiologies de douleur thoracique aiguë ?

- A. Douleur thoracique d'apparition brutale, maximale d'emblée
- B. Asymétrie tensionnelle ou de pouls entre les deux bras
- C. Souffle diastolique aortique
- D. Douleur augmentant à l'inspiration profonde
- E. Elévation modérée des troponines

3) Quels mécanismes peuvent expliquer l'hypotension artérielle observée dans ce cas ?

- A. Tamponnade par rupture dans le péricarde
- B. Hypovolémie par rupture dans la cavité pleurale
- C. Compression des artères coronaires
- D. Insuffisance aortique aiguë
- E. Activation massive du système parasympathique

4) Quels examens peuvent contribuer au diagnostic positif en urgence ?

- A. Échographie transœsophagienne
- B. Angioscanner thoracique
- C. Dosage des D-Dimères
- D. Coronarographie immédiate
- E. Échographie transthoracique

Cas clinique 4

Une femme de 62 ans, ayant comme antécédent un cancer bronchique métastatique, consulte pour une douleur thoracique rétrosternale et oppressante, installée progressivement depuis 2 jours, avec dyspnée au moindre effort, fatigue, et épisodes de vertiges.

À l'arrivée : elle est pâle, polypnéique (28/min), TA : 85/60 mmHg, pouls : 110 bpm, SpO₂ : 92% à l'air ambiant, jugulaires turgescentes, bruits du cœur assourdis, extrémités froides.

1) Quels éléments dans ce tableau orientent spécifiquement vers une tamponnade cardiaque ?

- A. Le terrain
- B. La Tachycardie à 110 BPM
- C. La turgescence jugulaire
- D. L'abaissement des bruits du cœur
- E. La dyspnée d'effort et l'orthopnée

2) Quels examens sont utiles en première intention ?

- A. Échocardiographie transthoracique
- B. ECG 12 dérivations
- C. Radiographie thoracique
- D. Dosage de troponine
- E. Scanner thoracique injecté

3) Quels signes échographiques sont typiques d'une tamponnade ?

- A. Épanchement péricardique abondant
- B. Collapsus diastolique de l'oreillette droite
- C. Collapsus diastolique du ventricule droit
- D. Dilatation de la veine cave inférieure sans variation inspiratoire
- E. Hypertrophie pariétale ventriculaire gauche

4) Quelles complications peuvent survenir en cas de tamponnade non prise en charge ?

- A. Choc cardiogénique irréversible
- B. Ischémie myocardique secondaire à la baisse du débit coronarien
- C. Embolie pulmonaire massive
- D. Arrêt cardiaque par asystolie
- E. Hypertension artérielle pulmonaire sévère

Cas clinique 5

Patient âgé de 45 ans consulte aux urgences pour une douleur thoracique aiguë. Dans ses antécédents, on retrouve une hypertension artérielle, diabète de type 2 et un tabagisme actif à 40 paquets années. Il vous rapporte que son père il est décédé d'un infarctus du myocarde à l'âge de 70 ans. Ces douleurs sont décrites comme étant continues évoluant depuis 2 heures, rétrosternales à type de constriction et irradiant vers l'épaule gauche. A l'examen, la TA est à 120/60 mm Hg, un pouls régulier à 100 BPM et une SpO₂ : 96%. L'auscultation cardiaque et pulmonaire sont sans particularités. L'ECG montre un bloc de branche gauche complet.

1) Les facteurs de risque cardiovasculaire retrouvés chez ce patient sont :

- A. L'âge
- B. L'hypertension artérielle
- C. Le diabète
- D. Le tabac
- E. L'hérédité cardiovasculaire

2) Les caractéristiques de cette douleur thoracique vous font évoquer :

- A. Une douleur péricardique
- B. Une douleur pleurale
- C. Une douleur aortique
- D. Une douleur angineuse
- E. Une douleur pariétale

3) Le diagnostic le plus probable serait :

- A. Un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST
- B. Une dissection aortique
- C. Une embolie pulmonaire
- D. Une péricardite aiguë
- E. Un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST

4) La conduite à tenir que vous préconisez chez ce patient :

- A. Cycle de troponine US H3-H6
- B. Répéter ECG à H3-H6
- C. Dosage des D-Dimères
- D. Echographie cardiaque transthoracique au lit du patient
- E. Angiographie coronaire